

Normalità e Patologia nell'Età Evolutiva — Sintesi

I Tempi della Vita · Sessione 08

Questa lezione ti dà gli strumenti per distinguere quando un bambino sta faticando a crescere (normale) da quando sta soffrendo davvero (patologia). Non è mai ovvio — ma esistono quattro assi per orientarsi.

Cos'è la normalità? Quattro definizioni, tutte problematiche

- **Media statistica** → normale = nella media misurata (es. QI 85-115). Rischio: diventa prescrittiva, cristallizza le persone in punteggi
- **Ideale** → normale = corrisponde alle attese di genitori/scuola/società. Rischio: chi definisce l'ideale?
- **Processo dinamico** → normale = si adatta, è resiliente
- **Assenza di malattia** → normale = non malato. Definizione circolare

Gli **strumenti psicometrici** (ADOS-2, WISC-V, CBCL, Conners 3) sono utili per superare i bias clinici, ma vanno usati come strumenti — non come confini rigidi tra normale e patologico.

Il sintomo: un linguaggio, non solo un problema

- **Sintomo** = manifestazione soggettiva (riferita dal paziente)
- **Segno** = fenomeno oggettivo e misurabile

Winnicott: un bambino sano ha un repertorio flessibile di sintomi. L'assenza totale di sintomi può essere un segnale di allarme (falso sé, conformismo adattivo).

La patologia si manifesta come **rigidità** — i sintomi non fanno più il loro lavoro evolutivo.

Il sintomo in età evolutiva serve a: - Cercare un'organizzazione interna più adattativa - Fare una richiesta ai caregiver - Cercare significato quando mancano simbolizzazioni più mature

I sintomi vanno sia **ascoltati** (valore evolutivo) che **curati** (quando diventano un disturbo).

Due difficoltà specifiche della psicologia

1. **Nessun marker biologico** — non esiste l'esame che conferma la diagnosi psicologica
2. **Nessun sintomo patognomonico** — quasi nessun sintomo è univocamente legato a una sola diagnosi
 - Es. ansia → presente in quasi tutti i disturbi
 - Es. anedonia → normale adolescenza, depressione, o psicosi
 - Es. dispercezioni → esordio psicotico, sostanze, o disturbo del sonno

Attenzione: i sintomi **silenziosi** (negativi) sono spesso i più gravi. Le psicosi gravi esordiscono lentamente. Il 75-90% delle esperienze psicotiche subcliniche sono transitorie.

I quattro assi della valutazione

1. Asse Sindromico-Sintomatico

Raccoglie sintomi e li trasforma in segni. Due aree: - **Corpo**: alimentazione, sonno, controllo sfinterico, motricità, sessualità - **Comportamento**: aggressività, affettività, cognizione, linguaggio, regolazione

2. Asse Strutturale

Cerca l'organizzazione profonda del mondo psichico (nevrotico / borderline / psicotico). Autori: **Bergeret** (sintomi, difese, angoscia, relazione d'oggetto), **Kernberg** (identità, difese, esame di realtà), **Palacio Espasa e Dufour** (griglia specifica per età evolutiva).

Domanda chiave: il sintomo è **in relazione** con la maturazione o è un **ostacolo** a essa?

3. Asse Evolutivo

Valuta rispetto alle linee di sviluppo. **Regressioni e fissazioni** sono normali nelle transizioni. Esempi di fenomeni normali spesso scambiati per patologia: - Dismorfofobia lieve in adolescenza - Condotte a rischio come appetenza evolutiva del cervello adolescente - Fobie specifiche nei processi maturativi - Ossessioni circoscritte nella fase di latenza

4. Asse Ambientale

Il sintomo è spesso il risultato del sistema individuo-ambiente. Valutare: - Microsistema (famiglia, relazione genitori-bambino) - Mesosistema (scuola, rete sociale) - Macrosistema (cultura)

Caso James (esempio pratico)

- Bambino con aggressività, incubi, selettività alimentare, difficoltà di regolazione
 - Contesto: genitori giovanissimi, padre assente, madre con disturbo di personalità
 - Diagnosi: disturbo misto emozioni e condotta (F92.9) + fragilità psicosociale
 - Intervento: psicoeducativo a domicilio + lavoro di rete + psicoterapia relazionale
-

Da ricordare: - **Sintomo** $\neq$ **patologia** — il sintomo flessibile è normale, la rigidità è il segnale d'allarme - **Quattro assi:** sindromico, strutturale, evolutivo, ambientale — tutti necessari, nessuno basta da solo - **Non esistono sintomi patognomonici** in psichiatria: la diagnosi è sempre un'interpretazione contestuale